UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Corso di Laurea in Logopedia

MALOCCLUSIONI DI II CLASSE:

L'USO DELLA TERAPIA MIOFUNZIONALE IN UN PAZIENTE ADULTO E PROPOSTA QUESTIONARIO PER LA QOL

Relatore:
Prof.ssa **Patrizia Lopez**

Tesi di laurea di:
Eleonora Mariotti

Anno Accademico 2021/2022

MALOCCLUSIONI

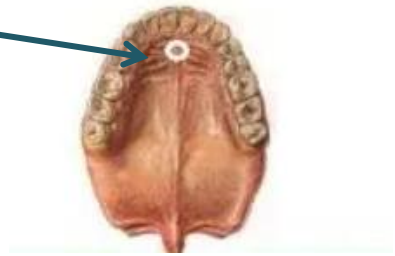
- Deviazione apprezzabile dall'occlusione ideale che può essere considerata esteticamente insoddisfacente (Houston, et al., 1992) e che implica una condizione di squilibrio nelle dimensioni e nella posizione dei denti, delle ossa facciali e dei tessuti molli.

- Ossee, dentarie, dento-scheletriche.

DEGLUTIZIONE DISFUNZIONALE E TERAPIA MIOFUNZIONALE

E’ una problematica di natura miofunzionale, caratterizzata dalla persistenza del meccanismo deglutitorio di tipo infantile oltre il periodo considerato fisiologico.

Alterazione della postura della lingua che non si posiziona a livello dello spot palatale.



La TMF è un trattamento funzionale che usufruisce dell’applicazione delle forze muscolari per raggiungere un equilibrio o un bilanciamento della muscolatura oro-facciale (Andretta,2005), attraverso l’educazione e rieducazione delle funzioni orali.

MALOCCLUSIONI E QOL

- Produce sentimenti di inferiorità;
- Riduce l’autostima;
- Altera la propria immagine corporea;
- Compromette: il benessere psicologico ed emotivo e la capacità di instaurare relazioni.

OBIETTIVI DELLO STUDIO

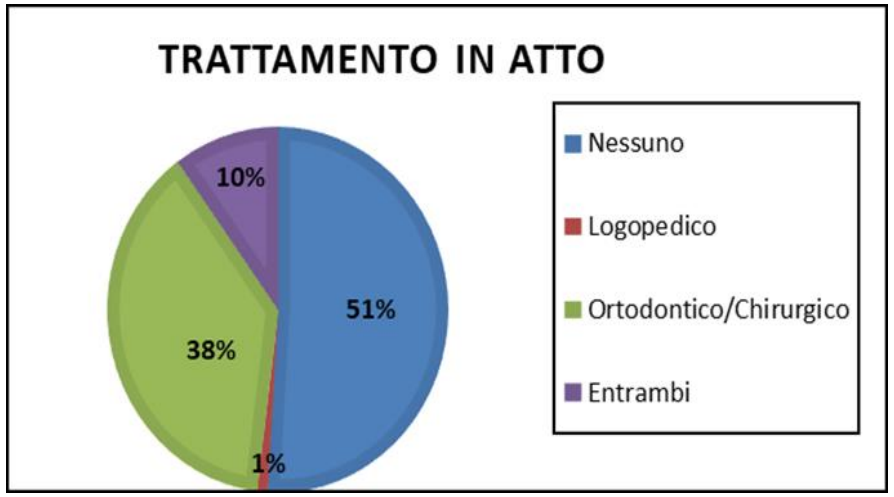
- Indagare l’impatto di tale problematica su diversi aspetti della qualità della vita di persone adulte, attraverso il questionario « QoL- MALOCCLUSION».

- Verificare gli effetti dell’applicazione della TMF durante la fase di ortodonzia pre-chirurgica in una paziente, me stessa, con malocclusione dento-scheletrica di II classe.

MATERIALI E METODI

- Il questionario è stato fatto compilare a 73 persone adulte.

CRITERI DI INCLUSIONE	CRITERI DI ESCLUSIONE
➢ Adulti con età compresa tra i 18 e i 55 anni; ➢ Presenza di malocclusioni dentali o dento-scheletriche; ➢ Consapevolezza della propria problematica.	➢ Soggetti in età evolutiva e adolescenziale; ➢ Presenza di deficit cognitivi.



- Forma cartacea e online.

QoL- MALOCCLUSION

Questionario della qualità di vita – malocclusione

Questionario anonimo

ETA': .....

	MAI (0)	A VOLTE (1)	SPESSO (2)	SEMPRE (3)
1. Percepisce che la gestione di cibo di diverse consistenze sia difficoltosa?	□	□	□	□
2. Evita di mangiare cibo di determinate consistenze? (ad esempio croccante)	□	□	□	□
3. Prova imbarazzo nel mangiare fuori casa?	□	□	□	□
4. La mattina le capita di trovare il cuscino bagnato di saliva, questo le crea imbarazzo quando deve dormire fuori casa?	□	□	□	□
5. Si sente in imbarazzo quando deve conoscere e parlare con persone nuove?	□	□	□	□
6. Quando è fuori casa cerca di nascondere il proprio volto? (ad esempio con i capelli o una sciarpa)	□	□	□	□
7.Si nasconde di fronte all'obiettivo della macchina fotografica?	□	□	□	□
8. Percepisce che le persone la stiano fissando mentre sta parlando?	□	□	□	□
9. Evita di farsi vedere con il volto di profilo?	□	□	□	□

	MAI (3)	A VOLTE (2)	SPESSO (1)	SEMPRE (0)
10. Le piace il suo sorriso?	□	□	□	□

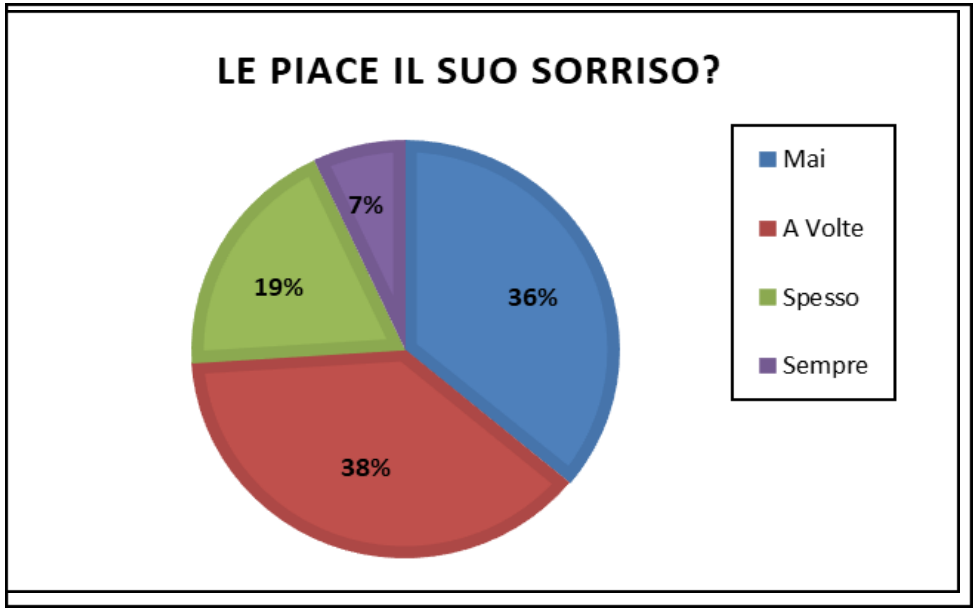
QUESTIONARIO

RISULTATI

La malocclusione influenza la qualità di vita.

Aree maggiormente influenzate dalla malocclusione:

- la percezione circa la gestione di cibo di diverse consistenze;
- la tendenza a sottrarsi o a nascondersi di fronte alla macchina fotografica;
- l'attitudine ad evitare di far vedere il viso di profilo;
- la percezione degli sguardi su di sé durante uno scambio comunicativo;
- Il grado di soddisfazione del proprio sorriso.

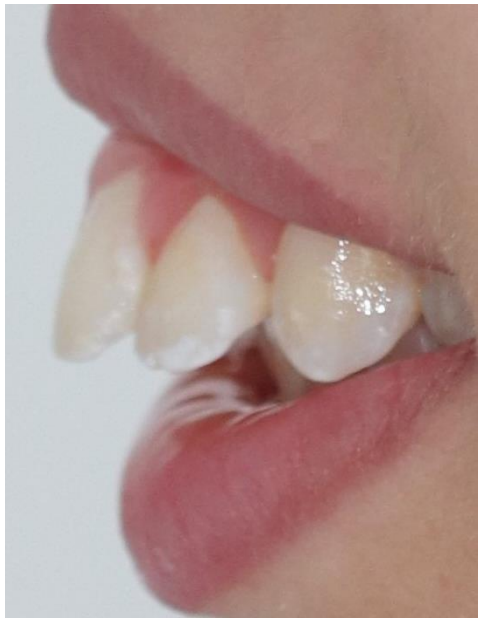


Non è possibile affermare che vi sia una relazione diretta tra età e gravità dell'impatto.









Situazione nel 2020

APPLICAZIONE DELLA TERAPIA MIOFUNZIONALE IN UNA PAZIENTE ADULTA

Diagnosi: malocclusione di II classe dento-scheletrica nel 2020. Deglutizione disfunzionale.

Età: 21 anni

Trattamenti in atto: ortodontico-chirurgico

MATERIALI E METODI

Valutazione iniziale e finale: OMES
ProVaLoRe
QoL-MALOCCLUSION

Durata : 12 mesi, fine di settembre 2021 - inizio ottobre 2022.

In contemporanea con il percorso ortodontico.

Frequenza: - un incontro ogni due settimane per i primi dieci mesi.
- una seduta mensile negli ultimi due mesi.

- Fotografie
- Misurazioni

EVOLUZIONE dei RISULTATI

Foto ad un mese dall'inizio del trattamento



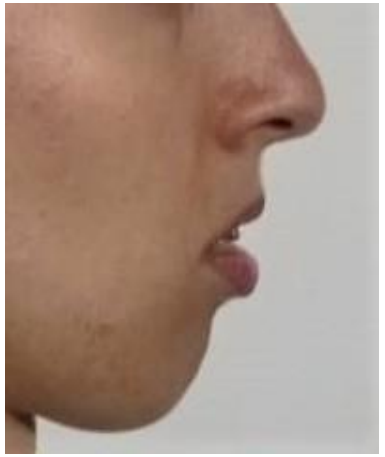
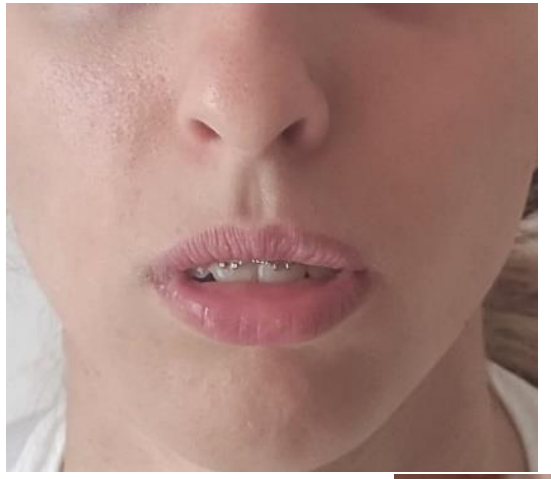
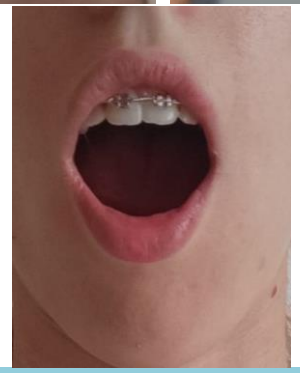




Foto al termine della terapia







RISULTATI

- ✓ protocollo “ OMES” : **82 → 87** (cut-off< 88).
- ✓ protocollo “ProVaLoRe”: **38→ 29**.

Alterazione delle strutture indagate, con passaggio dal grado moderato a lieve.

- ✓ respirazione, seppur di tipo ancora oronasale, appare di grado ridotto.
- ✓ Questionario “QoL-MALOCCLUSION”: **21 (grado moderato-severo) → 15 (lieve-moderato).**
- ✓ Aumento ampiezza apertura della bocca di 3 millimetri.
- ✓ Ampiezza dell’angolo naso-labiale aumentata di circa dieci gradi.
- ✓ Riduzione del grado di contrazione del muscolo mentoniero e dello stato di tensione generale.

LIMITI DELLO STUDIO

- Assenza di informazioni relative al genere, al grado e al tipo di malocclusione dei soggetti che hanno compilato il questionario “QoL-MALOCCLUSION”;
- Studio su caso singolo;
- Assenza di una rivalutazione in seguito all’intervento chirurgico.



Somministrare « QoL- MALOCCLUSION» agli adolescenti per effettuare confronto con i dati ottenuti nel presente studio.

CONCLUSIONI

Riduzione della QoL di persone adulte a causa della malocclusione

Utilità dell'applicazione della TMF in un soggetto con severa malocclusione dento-scheletrica di II classe durante la fase pre-chirurgica, nonostante, non sia possibile parlare di una piena risoluzione del disturbo.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

